

Срыгивания и ГЭРБ

Норма или болезнь · шкала ESPGHAN · красные флаги · АР-смеси и эзомерпазол

1. ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА

	Срыгивание и руминация (P92.1)	ГЭРБ (P78.8)
Суть	Функциональное расстройство ЖКТ: пассивный заброс без напряжения брюшного пресса и вегетативных реакций	Заброс содержимого желудка вызывает беспокоящие симптомы и/или осложнения
Частота	При строгих Римских критериях IV ежедневные срыгивания у 10,5–86,9% младенцев; без критериев — почти у 100%	У 1 из 10 детей, поступивших в ОРПН
Когда проходит	Спонтанно к 12–15 месяцам; НПС созревает к 6 месяцам	Симптоматика у младенцев в большинстве случаев исчезает самостоятельно после 6 месяцев
Диагноз	Клинический, по анамнезу и осмотру	Диагноз исключения — специфичных симптомов нет

Нет красных флагов — нет обследований и нет лечения
Если симптомы не влияют на кормление, рост и развитие, то при отсутствии настораживающих признаков диагностические тесты и лечение, включая подавление кислотности, **не требуются**.

2. ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ СРЫГИВАНИЙ (ESPGHAN)

Балл	Характеристика
0	Срыгиваний нет
1	Более 5 срыгиваний в сутки объёмом не более 3 мл
2	Более 5 срыгиваний в сутки объёмом более 3 мл
3	Более 5 срыгиваний в сутки объёмом до половины одного кормления, не чаще чем в половине кормлений
4	Срыгивания небольшого объёма в течение 30 минут и более после каждого кормления
5	Срыгивания более половины полного объёма одного кормления, не менее чем в половине кормлений

3. КРАСНЫЕ ФЛАГИ

Жалобы	Находки при осмотре
Регургитация появилась на 1-2-й неделе жизни	Плохие прибавки или отсутствие прибавок массы тела
Рвота с примесью желчи; ночная или постоянная рвота; рвота фонтаном	Выраженное вздутие живота
Гематемезис	Лихорадка
Хроническая диарея или диарея с кровью	Вялость или повышенное беспокойство
Дисфагия, одинофагия, затруднения при глотании	Выбухание большого родничка, быстрый прирост окружности головы, микро- или макроцефалия
Рецидивирующая пневмония, аспирации, длительный кашель, свистящее дыхание	Патологические изменения мышечного тонуса
Судороги, дизурия	Отклонения в психомоторном развитии
Синдром Сандифера: пароксизмальная кривошея, дистонические движения тела	Отклонения со стороны пищеварительной, дыхательной и нервной системы

Регургитация на 1–2-й неделе жизни требует исключения инфекционных заболеваний, анатомических аномалий и метаболических нарушений — именно поэтому при дебюте на первой неделе назначаются общий анализ крови, КОС и газы крови, лактат и аммиак.

4. КТО В ГРУППЕ РИСКА ПО ГЭРБ

Группа	Что именно
Краниофациальные аномалии	Хейлосхизис
Дыхательные пути	Трахеоэзофагеальная фистула
Диафрагма	Врождённая диафрагмальная грыжа, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Передняя брюшная стенка	Дефекты брюшной стенки
ЖКТ	Атрезия пищевода, аномалии поворота кишечной трубки, стеноз привратника, атрезия двенадцатиперстной и других отделов тонкой кишки, стриктуры кишечника, кольцевидная поджелудочная железа
Нервная система	ВЖК, перивентрикулярная лейкомаляция, гипоксически-ишемическая энцефалопатия

Триггеры расслабления НПС	Вздутие живота, напряжение передней брюшной стенки, РДС, терапия производными ксантина	Ассоциированные состояния	Апноэ недоношенных, БЛД — но уровень доказательности этой связи низкий
---------------------------	---	---------------------------	---

Факторы риска срыгиваний по КР 962_1: ГВ менее 32 недель, масса при рождении менее 1,5 кг, кесарево сечение, ранний перевод на искусственное вскармливание, антибиотики у матери или ребёнка, госпитализация дольше 7 дней, аллергия на БКМ, курение матери, тугое пеленание, перекорм и нарушение техники кормления.

5. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ГЭРБ

Метод	Когда	Что даёт
ЭГДС	При подозрении на ГЭРБ, особенно при тревожных симптомах	Степень поражения слизистой (I–IV), эрозивный эзофагит, врождённые аномалии пищевода
Биопсия пищевода	При отсутствии эффекта от терапии	Исключение эозинофильного эзофагита. Не менее 2 биоптатов (лучше 4) на 2 см и выше от Z-линии
Суточная рН-метрия	При отсутствии эффекта от терапии	Индекс рефлюкса — доля времени с pH < 4. Не видит слабокислый рефлюкс , а это до 73% эпизодов у младенцев
рН-импедансометрия	При отсутствии эффекта от терапии	Кислотный и некислотный рефлюкс, высота заброса, риск аспирации
Рентгеноскопия с контрастом	Подозрение на грыжу пищеводного отверстия или диафрагмальную грыжу; рефрактерное течение (нет ремиссии за 4–8 недель терапии)	Специфичность в диагностике СГПОД 94%. Малые грыжи может пропустить , лучевая нагрузка высокая

Степени эзофагита при ЭГДС: **I** — очаговая эритема и рыхлость абдоминального отдела; **II** — тотальная гиперемия с фибринозным налётом и одиночными несливающимися эрозиями; **III** — воспаление и эрозии переходят на грудной отдел; **IV** — язва или язвы пищевода, стеноз.

6. ЛЕЧЕНИЕ: СТУПЕНЬ ЗА СТУПЕНЬЮ

Степень	Что делать	Оценка
1. Поза	Кормить, держа ребёнка под углом 45-60° ; после кормления вертикально 20-30 минут с приподнятой головой; головной конец кровати выше на 10-15 см . Положения на животе и на левом боку дома не применять — риск СВДС	Вместе с диетой эффективность 90-95%
2. Режим кормления	Не перекармливать. На грудном — спокойная обстановка, правильное прикладывание против аэрофагии. На искусственном — чаще и меньшим разовым объёмом	
3. АР-смеси	Загуститель — камедь рожкового дерева или модифицированный крахмал. Крахмальные назначают в полном суточном объёме	Если за 2 недели (по КР 962_1 — 2-4) улучшения нет — тактика неэффективна
4. Гидролизаты	Смеси на основе высокогидролизованного белка или аминокислотные — особенно при признаках атопии	При эффекте продолжать до 12 месяцев, но не менее 6
5. ИПН	Эзомепразол 0,5 мг/кг в сутки на 1 приём внутрь, курс 4-6 недель	Только при выраженных симптомах и эзофагите средне-тяжёлой и тяжёлой степени
6. Хирургия	Фундопликация, предпочтительно лапароскопическая (по Ниссену, реже Талю, Дору, Тоупе)	Стойкий эзофагит III-IV степени после неоднократных курсов, кровотечения, стриктуры, сочетание с СГПОД

Рутинно медикаменты не назначаются

При неосложнённом ГЭР рутинная медикаментозная терапия **не рекомендуется**: эффективность недостаточна, данных по безопасности мало. Имеющиеся данные не подтверждают эффективность ИПН при характерных симптомах ГЭРБ у новорождённых, а у **недоношенных кислотосупрессивную терапию применять не следует** из-за риска серьёзных побочных эффектов. При срыгиваниях и руминации лекарственная терапия вообще не применима.

- АР-смеси — лечебные: назначает врач, объём подбирается индивидуально (1/2, 1/4 от кормления, 1-3 раза в день или полный суточный объём на 2-4 недели), срок ограничен, здоровым детям без срыгиваний они не нужны.
- Эффект крахмальной АР-смеси наступает позже, чем у смеси с камедью.
- Длительность приёма АР-смеси индивидуальна, иногда до 2-3 месяцев; на стандартную смесь переводят только после стойкого эффекта.

7. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ВЫПИСКА ПРИ СРЫГИВАНИЯХ

Госпитализировать	Выписывать
Упорные срыгивания, не поддающиеся коррекции	Симптомы тревоги купированы
Стойкие выраженные симптомы тревоги: срыгивания, чередующиеся рвотой, примесь крови или желчи — со значительной потерей массы, обезвоживанием, электролитными и обменными нарушениями	Состояние стабилизировано
Респираторные симптомы, связанные со срыгиваниями: ларингоспазм, бронхоспазм, афония, кашель	Исключена органическая природа — хирургическая, инфекционная, эндокринная, обменная, аллергическая, неврологическая

Синдром руминации по Римским критериям требует симптомов не менее **2 месяцев**, дебюта в **3-8 месяцев**, отсутствия ответа на лечение ГЭРБ и регургитации; руминация не бывает во сне и при взаимодействии ребёнка с окружающими.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь новорожденных» — ID 950_1, размещены 08.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/950_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Срыгивание и руминация новорожденного» — ID 962_1, размещены 12.11.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/962_1
- Факторы риска, степени эзофагита, методы диагностики, ступени терапии и доза эзомепразола приведены по разделам 1–3 КР «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь новорожденных»; шкала интенсивности срыгиваний, красные флаги, постуральная и диетическая коррекция, показания к госпитализации — по разделам 1, 2, 3 и 6 КР «Срыгивание и руминация новорожденного».